
4. Observation n° 15 : Andrée et les voix du passé

4.1 Le premier entretien

Andrée est une femme de 40 ans qui a été hospitalisée en psychiatrie pour troubles anxio-dépressifs après un passage à l'acte suicidaire. Elle se présente comme une femme complètement effondrée et très amaigrie. Les psychiatres sont inquiets par son état et évoquent une personnalité pathologique.

À notre premier entretien, Andrée s'exprime aisément et associe facilement, mais elle pleure beaucoup. Elle évoque spontanément un contexte de harcèlement sexuel au travail qui semble avoir été traumatisant.

Andrée se décrit comme une femme autrefois très active qui s'est beaucoup battue au cours de sa vie ; elle a élevé seule ses deux filles après une séparation difficile avec son ex-mari. Son parcours professionnel a été pénible ; peu diplômée, elle a souvent enchaîné des « petits boulots » dans le cadre de contrats à durée déterminée mais, il y a trois ans, elle a pu enfin obtenir un emploi stable dans un grand restaurant. Elle était très reconnaissante envers son patron pour son soutien dans l'obtention de son contrat de travail. Mais très peu de temps après, son patron se montre très entreprenant et souhaite avoir des relations sexuelles avec elle.

Andrée, très choquée, ne comprend pas son attitude et se remet en cause en se justifiant ; elle n'a jamais eu aucun comportement déplacé, sa tenue vestimentaire n'a jamais été provocatrice.

À partir de ce moment, Andrée tente d'éviter son patron, lui fait comprendre qu'il n'est pas question d'avoir de relations. Elle se sent très vexée qu'on ait pu penser d'elle qu'elle pouvait être une femme facile, alors que sur son lieu de travail, elle a toujours veillé à cacher sa féminité pour ne pas attirer les hommes. Les sollicitations sexuelles de son patron lui font honte et elle n'en parle pas à son compagnon.

Mais progressivement, son patron adopte des comportements grossiers : il la chahute dès qu'ils sont à proximité ; exprime des paroles « crues » et humiliantes devant ses collègues de travail, en majorité des hommes, qui, selon Andrée, ne réagissent pas. Au contraire, les paroles du patron sont sources de plaisanteries salaces, « ce ne sont que des machos », dit-elle. Mais rien ne semble arrêter le comportement harcelant de son patron, qui devient de plus en plus agressif, et les paroles se font cette fois violentes. Selon Andrée, il commence à l'insulter avec

des termes qu'elle n'ose répéter, « traînée... bonne à rien... p... », et un jour, alors qu'elle se refuse à lui, il la pousse violemment. Andréa finit par « craquer » et ne peut plus revenir sur le lieu de son travail. Elle entre alors progressivement dans une profonde dépression et est hospitalisée à la suite d'une tentative de suicide.

Lorsque je demande à Andréa ce qui a été le plus difficile à vivre dans le comportement de son patron, elle me répond que ce sont essentiellement ses paroles insultantes, humiliantes, qui la rabaissaient sans cesse. Elle avait l'impression de n'avoir aucune valeur, d'être comme un « déchet ». Aujourd'hui, ce sont encore ces paroles qui ont une valeur traumatique, elle ne cesse d'y penser. Ces paroles résonnent de manière incessante dans sa tête comme si elle les entendait encore. Andréa se sent profondément déprimée, dévalorisée, elle rumine sans cesse ses souvenirs de harcèlement, elle voit constamment le visage de son patron qui se moque d'elle. Elle se sent profondément bouleversée, anéantie, elle a l'impression de n'être plus rien, de n'avoir aucune valeur, alors qu'elle a toujours été très forte dans sa vie, active et déterminée. Elle ne comprend pas pourquoi aujourd'hui elle se sent aussi effondrée et fragile, les idées suicidaires ne la quittent plus.

4.2 Discussion : harcèlement traumatique, quelle écoute du clinicien ?

4.2.1 Une écoute empathique dans l'ici et maintenant

Dans un premier temps, il est nécessaire d'adopter une écoute dans l'ici et maintenant pour Andréa, ce qui implique d'écouter sa détresse, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent de la situation, en l'amenant à développer son point de vue, son vécu, ses difficultés, et en lui montrant combien cette expérience a été importante et éprouvante pour elle. Cette écoute active dans le présent et dans la réalité est à la base du partage de l'expérience émotionnelle et du sentiment d'être compris pour le patient. C'est un des éléments les plus importants du premier entretien qui permet d'enclencher le processus thérapeutique. Le patient doit sentir que le thérapeute est là disponible, prêt à l'écouter. Ce partage d'expérience crée une relation de confiance et facilite le développement d'une bonne qualité de l'alliance thérapeutique qui est la base essentielle et centrale de tout processus thérapeutique. Il s'agit de constituer un appui pour le patient et de l'amener à s'exprimer avec confiance, à dire ses affects, ses colères, afin de permettre une certaine libération émotionnelle. L'aspect

cathartique des premières séances ne peut avoir lieu que dans un tel climat de compréhension empathique.

Bien que ces dimensions puissent apparaître simples ou banales, elles relèvent pourtant de la condition même du processus thérapeutique. En clinique, nous sommes souvent amené à rencontrer des patients qui n'ont parfois jamais verbalisé leurs difficultés, leurs angoisses, et la possibilité de parler et d'être attentif à sa vie intérieure n'est pas un travail qui va de soi. Pourtant, l'enjeu thérapeutique est d'amener ces patients à retrouver des significations et une cohérence interne à ce qu'ils viennent de vivre. Ainsi, l'écoute empathique sans jugement, positive, du clinicien est ce qui permet au patient d'être accompagné dans ce voyage intérieur et de ne pas en avoir peur.

4.2.2 L'écoute inférentielle

L'écoute empathique uniquement centrée dans l'ici et maintenant ne suffit généralement pas et il faut également un deuxième niveau d'écoute en relation avec l'activité inférentielle du clinicien.

Ce deuxième niveau dépasse les aspects manifestes et tente de s'intéresser au niveau latent de la problématique qui est présentée. Ici, ce qui est écouté n'est pas seulement le récit en tant que tel, mais il va s'agir de chercher à comprendre les réactions du sujet. Le clinicien opère ainsi une activité de mise en sens qu'il ne signifie pas nécessairement au patient dans l'immédiat. Ces inférences font partie de son système théorique et de la manière dont il construit les objectifs thérapeutiques. Ainsi, chez Andréa, au-delà de la nécessité de reconnaître la valeur traumatique du présent, il s'agira aussi de s'interroger sur le pourquoi d'une réaction si forte, pourquoi ce désir suicidaire, pourquoi se sentir comme un déchet, pourquoi les paroles de cet homme l'ont-elle autant ébranlée ? Qu'est-ce qui a pu faire résonance chez elle dans ces paroles violentes ? L'écoute est un travail de pensée, d'analyse et d'association chez le clinicien qui aide à mieux comprendre le patient. Ces associations permettent au clinicien d'avoir une hypothèse et une théorie pouvant rendre compte du problème du sujet puis d'avoir une stratégie thérapeutique pour résoudre celui-ci. Ce travail de compréhension est long, il se construit progressivement en fonction des éléments des entretiens. Il fait partie des inférences du clinicien, qui se questionne sur les moments propices de l'intervention thérapeutique elle-même. Est-il par exemple opportun d'investiguer avec le patient un niveau de résonance avec son passé ?, si oui, comment et à quel moment de la psychothérapie ? Comment cela

doit-il être traité ? Sinon, quelles sont les autres modalités de l'intervention thérapeutique ?

Chez Andréa, les humiliations répétées sont en elles-mêmes sources d'un processus traumatique et aliénant qui se comprend sans doute à la lumière de sa relation particulière à son patron, et en particulier par son admiration passée pour ce dernier. Il y a donc chez elle une lourde déception qui doit être interrogée en fonction de ce qu'elle peut réactiver dans son histoire, sans toutefois méconnaître les aspects traumatiques de la situation de harcèlement. Il est important de s'interroger sur la manière dont cet événement prend sens dans l'histoire d'un sujet, non pas dans le cadre d'une théorie explicative et rétrospective, mais comme un moyen de réappropriation subjective d'une histoire individuelle qui a été effractée et qui nécessite d'être reconstruite en donnant de nouvelles significations aussi bien au présent qu'au passé.

4.3 Le début du processus associatif : les voix du passé

Nous commençons une psychothérapie de soutien avec Andréa et nous décidons également avec mes collègues de la mise en place d'une consultation psychiatrique parallèle pour le traitement médicamenteux et le suivi de la procédure sociale et judiciaire.

Dès le deuxième entretien, Andréa fait part de son sentiment d'avoir trouvé un réel soutien auprès du psychiatre référent et de moi-même ; elle s'est sentie comprise et reconnue et elle pense que cela lui donne le courage de se battre. En effet, lors de sa dernière permission, elle s'est montrée plus active et a contacté les syndicats qui l'ont soutenue dans son affaire et elle s'est décidée à porter plainte pour harcèlement contre son patron.

Elle évoque ensuite à nouveau longuement son agression, son patron qui la méprise, la considère comme une « moins que rien ». Elle pleure à plusieurs reprises au cours de cet entretien. Andréa est envahie par les paroles de son patron qui résonnent constamment dans sa tête, paroles qu'elle n'ose pas prononcer. Elle ne parvient plus à se détacher et à prendre de la distance par rapport à cette situation. Elle se sent complètement effondrée.

Je l'écoute longuement dans cette souffrance actuelle et la soutiens par mes interventions. Mais en même temps, mes activités associatives mènent vers des questionnements relatifs à son enfance. Je ne peux m'empêcher face à la souffrance extrême d'Andréa et à l'intensité de sa

culpabilité de faire l'hypothèse d'une réactivation d'un traumatisme de l'enfance. Mais il est beaucoup trop tôt pour aborder ces éléments, et Andréa est trop prise par le présent et la douleur actuelle, ce qu'il faut respecter.

Je saisis l'occasion d'aborder ses relations familiales alors qu'elle me raconte qu'elle a repris récemment ses activités de peinture. Je lui fais part de mon intérêt pour ses qualités artistiques, et Andréa est très fière de me décrire ses réalisations. Je lui demande alors si ce sont ses parents qui lui ont transmis ce savoir-faire. Elle me répond qu'elle doit tout à son père, à qui elle était très attachée. Celui-ci a semble-t-il eu une vie rude en relation avec son travail et sa vie familiale, il n'a pas connu ses parents. Son père n'était pas très présent sur le plan familial, bien qu'il ait beaucoup compté pour elle.

Puis Andréa évoque sa mère. Je suis d'emblée surprise par son discours, devenu soudain très cru : elle me fait part de son dégoût et de sa haine pour sa mère. Elle me décrit sa mère comme une femme infidèle qui faisait venir ses amants à la maison rendant Andréa complice, car elle ne pouvait rien dire à son père. Andréa m'exprime son dégoût pour sa mère, qui n'a jamais eu aucune affection pour elle. Sa mère l'insultait régulièrement : « tu n'es qu'une traînée, une p... ! », et la frappait parfois violemment. Andréa me dit qu'elle comprenait sa mère : elle ne faisait que projeter ce qu'elle était elle-même. Elle ajoute qu'elle n'a jamais pu s'identifier à sa mère et qu'adolescente, elle était un véritable garçon manqué qui évitait la fréquentation des filles et n'appréciait que la relation avec les garçons.

Au troisième entretien, Andréa évoque d'importantes difficultés conjugales, car elle n'a plus aucun désir sexuel pour son compagnon, elle se sent sale et pleure. Elle ne supporte plus les hommes. Cette situation la rend profondément triste, car elle estime que son compagnon la soutient et la rassure. Andréa a du dégoût pour elle-même et ne supporte même plus de se regarder dans la glace.

Au cours de cet entretien, elle évoque à nouveau son enfance et son père, auquel elle était très attachée. Son père lui manque, et elle lui pardonne son peu d'affection, qu'elle relie à l'éducation rude de l'époque et à sa vie difficile.

Andréa évoque à nouveau la profonde rancune à l'égard de sa mère, qui n'a pas été disponible pour elle. Elle ajoute qu'elle s'est construite en opposition à sa mère et que paradoxalement, ce sont ses difficultés relationnelles avec sa mère qui l'ont armée dans la vie. Cette colère vive a constitué un moteur de résilience pour elle. Andréa s'est éloi-

gnée de sa mère pour s'identifier aux hommes, considérés comme des modèles, mais les hommes l'ont trahie. C'est sur ce sentiment profond de déception que nous avons principalement travaillé avec Andréa, et je lui signifie combien ces sentiments de trahison sont importants pour elle. Elle peut alors associer sur les différentes trahisons vécues : trahisons de son ex-mari volage, trahison de ses frères qui l'ont abandonné, trahison du père qui n'a pas su l'aimer, et enfin trahison de son patron, qu'elle admirait tant.

Dès le troisième entretien, Andréa fait le lien entre les paroles de ce dernier et les paroles de sa mère : « Tu n'es qu'une traînée... » Mais Andréa est effondrée par cette association, elle crie sa douleur, et se demande pourquoi cela se reproduit, pourquoi elle n'a pas pu se défendre contre son patron alors qu'elle avait la force de se défendre sa mère.

C'est la question profonde que nous avons eu à traiter avec Andréa au cours de trois années de suivi psychologique difficile. Andréa a oscillé entre des moments d'amélioration avec des capacités d'élaboration étonnantes qui permettaient un abord psychodynamique et des moments d'effondrement complet. Dans ces périodes, il fallait seulement développer une écoute et un soutien attentifs, une disponibilité psychique, jouer un rôle de contenant et de pare-excitation. Il s'agissait seulement d'être là et disponible, avec une écoute dans l'ici et maintenant, avec une mise en suspens d'un travail plus profond sur les significations. C'est avant tout une problématique abandonnique qui a été révélée au cours de ces entretiens qui ont pu être travaillés dans le transfert et nous avons pu évoquer à de multiples reprises sa peur d'être abandonnée par moi.

4.4 Conclusion

Andréa a pu se reconstruire après toutes ces années, l'accompagnement psychologique a constitué une grande part de ce soutien, mais cela a été aussi possible grâce à la reconnaissance du préjudice subi et à la réparation qui ont été essentielles dans son parcours. À la fin de la psychothérapie, malgré les blessures toujours présentes, Andréa avait recouvré son tempérament actif, la force de se battre à nouveau, et elle avait trouvé un nouvel emploi.